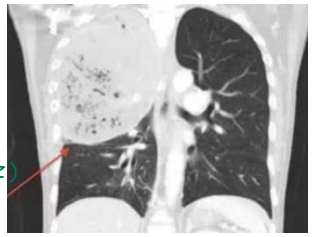
②中老年多见，常发生在 ttsx 醉酒、脑卒中等误吸
③急性起病，寒战高热，血 WBC↑ 也易发生厌氧菌感染的吸入性肺脓肿



3.影像学 痰液(渗出物)粘稠
①叶间隙下坠、蜂窝状脓肿 (伯伯年龄大下垂)不要速着一个点开跑(特别是影像学)
②易形成空洞，斑片或实变影

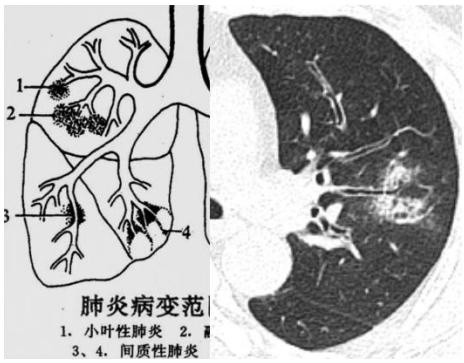
首选 保钾利尿剂:阿米洛利、氨苯蝶啶抑制集合管主细胞ENaC/阿米替林是三环类抗抑郁药
4.治疗：β-内酰胺类，重症联合喹诺酮类或氨基糖苷类（阿米卡星/妥布霉素）
千啊、脱单了

青霉素 头孢
针对G- 广谱青霉素 三、四代头孢

## （四）支原体肺炎

1.属于间质性肺炎

2.临床表现 病变累及间质→肺泡间隔增宽→刺激机体咳嗽,但肺泡内渗出少
①痰少，呈持久阵发性剧咳（发热退完后咳嗽还可持续存在）
②儿童、青年多见
③常有 ttsx 野游史 外出郊游史 一般肺炎:急性起病,寒战高热,WBC↑
④起病较缓（潜伏期约 2-3 周），一般低中热或不发热 特殊
⑤血 WBC 正常或略↑
⑥肺外表现（耳痛、皮疹等）多见
⑦具有自限性




3.影像学 后期累及实质,类似小叶性肺炎
①早期网格影，后期沿支气管/肺纹理散在分布的不规则斑片影、多累及双肺下叶
②不易形成空洞

4.确诊：血清支原体 IgM 抗体、冷凝集试验阳性

5.治疗
①因对大环内酯类如红霉素/罗红霉素/阿奇霉素（阿红达）高耐药，因此首选喹诺酮如左氧氟沙星/莫西沙星
注意：孕妇、哺乳、＜18 岁不用喹诺酮类 影响生长发育(软骨),但支原体又儿童多见

②四环素类也用于治疗支原体 导致四环素牙
③β 内酰胺类如青霉素、头孢菌素类对支原体无效 支原体衣原体无细胞壁
β内酰胺类抗生素通过阻止细胞壁内的肽聚糖交联发挥作用

## （五）军团菌肺炎 纤维素性化脓性炎

高频

1.军团菌 VS 支原体肺炎
（1）共同点 军团菌细胞壁的肽聚糖层很薄
①均属于非典型病原体（军团菌、支原体、衣原体）
注意：间质性肺炎指病毒、支原体、衣原体 (煎饼之一、滴点咪咪儿小透过气道和肺泡)
e.g 03年非典型肺炎不是指非典型病原体引起的肺炎,是SARS冠状病毒引起的病毒性肺炎
②野游史多见 军团菌易藏匿于未清洗空调
提起空调要想到 ①过敏性肺炎②军团菌